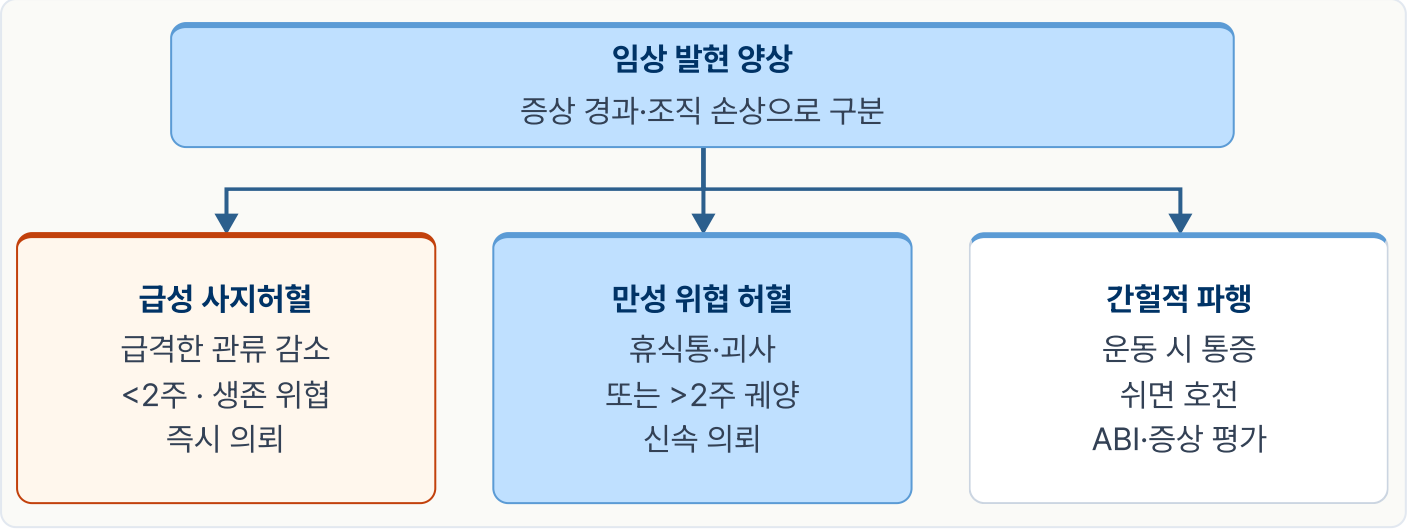
의료진 진료 카드 · ASL-013

하지 허혈 · 응급도부터 구분

증상 발생 속도와 휴식통·궤양·괴사로 의뢰 경로를 나눈다. 갑작스러운 변화는 2주를 기다리는 기준이 아니다.

임상 양상별 의뢰 · 세 갈래



본강의 · ALI와 CLTI의 정의

ALI	Acute limb ischemia: <2주 사이 급격한 사지 동맥 관류 감소로 사지 생존이 위협되는 상태.
CLTI	Chronic limb-threatening ischemia: PAD와 휴식기 통증·괴사 또는 >2주 지속 하지 궤양의 조합. 교재 정의는 정맥성·외상성·색전성·비죽상경화 원인을 제외한다.
파행	산소 요구량에 비해 혈류 공급이 부족해 운동 시 생기는 근육 통증. 하지의 협심증에 비유한 강의 설명.

연자 Q&A · ABI보다 증상이 우선인 경우

바로 의뢰	상처 또는 휴식기 통증은 ABI 결과와 무관하게 바로 의뢰. 장비가 없어도 족부 맥박이 약하거나 소실되면 의뢰 사유.
당뇨·상처·무측정	낫지 않는 상처가 있고 하지 혈압이 측정되지 않는 당뇨 환자는 CLTI로 보고 신속 의뢰한 판단이 맞다고 답변.

연자 Q&A: 상처·무측정 혈압의 CLTI 사례에서 clopidogrel 75mg 또는 aspirin 100mg과 고강도 스타틴을 바로 시작하며 의뢰 때문에 미룰 이유가 없다고 답변. 실로스타졸은 파행 개선 약으로 상처 치유 약을 대신하지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-013

CLTI · 상처·허혈·감염을 인계

재관류와 상처 치료를 함께 계획한다. 발끝 상처의 깊이·감염·관류와 사지 보존 가능성을 다학제로 평가한다.

본강의 · WIfI를 구성하는 세 축

W · wound

상처 깊이·범위·괴사. 얕은 원위부 궤양부터 뼈·관절·힘줄 노출·광범위 손상까지 0~3으로 평가.

I · ischemia / fI · infection

허혈은 ABI·발목압·발가락압 또는 $TcPO_2$, 감염은 피부·피하 국소부터 심부·전신 반응까지 각각 0~3으로 평가.

본강의 · 단계와 치료 목표

Stage 1~2	작은 말단 상처는 적절한 wound care·약물로 치유를 기대할 수 있다고 설명. 병기별 절단 위험을 함께 평가.
Stage 3~4	절단 위험이 높아 재관류와 괴사부 절단·재건을 함께 고려. 혈류를 회복하고 봉합·피판 부위가 낫게 하는 것이 목표.
다학제	혈관외과·심장내과·성형외과·내분비내과·정형외과가 재관류, debridement, flap·skin graft를 연결한다.

본강의 · 상처 위치에서 혈류 경로까지

Angiosome	장골·표재대퇴동맥 inflow에서 전경골·후경골·비골동맥을 거쳐 발의 목적지까지 target artery pathway를 확보하는 개념.
치료 선택	혈관내 치료(EVT/PTA), 내막절제술·성형술, 우회술 등으로 혈류 회복. 환자·병변·상처에 따라 재건·절단을 함께 결정.

본강의 증례: 71세 남자, CABG 병력과 발등 핫팩 화상 후 5주간 악화된 상처·힘줄 노출. 대퇴동맥 폐색에 debridement·우회술·피판/피부이식 후 3~6개월에 사지 보존. 당뇨가 없다는 이유만으로 혈관 원인을 제외하지 않는다.